TMO EPM · EPISÓDIO 93 · RESUMO DO JOURNAL CLUB

LLA Ph+ sem quimio na 1ª linha?

Ponatinibe + blinatumomabe vs imatinibe + quimioterapia em adultos com LLA Ph+ recém-diagnosticada — GIMEMA ALL2820, Chiaretti S et al. (N Engl J Med 2026)

O estudo

Ensaio de **fase 3, aberto, randomizado 2:1** (GIMEMA, Itália), adultos ≥18 anos **sem limite superior de idade**. **Intervenção:** ponatinibe até o dia 70 e depois **2 a 5 ciclos de blinatumomabe** com ponatinibe contínuo. **Controle:** imatinibe + 4 a 6 ciclos de quimioterapia, com **crossover** para pona + blina se a DRM persistisse. Transplante alogênico guiado por biologia: DRM positiva após a consolidação, ou IKZF1 plus com DRM positiva ou não quantificável. Desfecho primário: **sobrevida livre de eventos** (inclui não atingir resposta molecular completa).

236	158	78	23,7 m
randomizados	pona + blina	imatinibe + quimio	seguimento mediano

Resultados principais (estimativas em 24 meses)

	Pona + blina (n = 158)	Imatinibe + quimio (n = 78)
Sobrevida livre de eventos (primário · P < 0,001)	**86%**	67%
Sobrevida livre de eventos molecular (sem DRM)	**68%**	42%
Sobrevida global*	90%	85%
Recaída (incidência cumulativa)*	5%	13%
RC hematológica no dia 70	94%	79%
Morte na indução	3%	9%
Resposta molecular após a consolidação	**71%**	49%
Eventos adversos graves	34%	47%

* Desfechos secundários, sem teste formal de hipótese nem ajuste para multiplicidade. Resposta molecular = resposta molecular completa ou positiva não quantificável.

Transplante e crossover

- Dos pacientes em remissão com pona + blina, só **19%** (29 de 149) foram ao transplante alogênico na 1ª remissão; no controle, 26% (16 de 62).
- Dos **31** pacientes do controle que cruzaram para pona + blina (todos com DRM positiva), **20** ficaram com DRM negativa.
- Eventos cardiovasculares graves foram raros e apareceram só com a dose de 45 mg de ponatinibe, mais em idosos.

© 2026 TMO EPM · reprodução somente com autorização do canal · EPM-Unifesp / Hospital Nove de Julho

Leitura crítica

- **Comparador de outra época:** imatinibe + quimio. No PhALLCON, ponatinibe + quimio já tinha superado imatinibe + quimio em resposta molecular.
- **Duas mudanças ao mesmo tempo:** troca o ITK e troca a quimio pelo blinatumomabe. A resposta molecular no dia 70 foi parecida (47% vs 44%); a diferença surge depois do blinatumomabe (71% vs 49%).
- **Desfecho composto:** não atingir resposta molecular completa conta como evento, assim como morte.
- **Seguimento curto** (23,7 meses) para uma estratégia que reduz o transplante; recaída tardia ainda em aberto.
- **Cardiopatas excluídos** (QTc longo, infarto recente, insuficiência cardíaca, hipertensão não controlada).
- **Crossover** ajuda o paciente e dilui a comparação de sobrevida global.

O que dá para levar

- Na LLA Ph+ do adulto, ponatinibe + blinatumomabe sem quimioterapia superou imatinibe + quimio em sobrevida livre de eventos.
- Mais DRM negativa, menos recaída, menos morte na indução e menos eventos adversos graves.
- Pona ou dasa com blinatumomabe? O estudo não responde: pesa o perfil cardiovascular do paciente.
- Na discussão do episódio: o transplante fica para DRM positiva ou IKZF1 plus, e o tema não é consenso.

Contexto

D-ALBA (GIMEMA LAL2116, fase 2, dasatinibe + blinatumomabe sem quimio): em 53 meses, sobrevida livre de doença 75,8%, global 80,7% e livre de eventos 74,6%.

Referência

Chiaretti S, Piciocchi A, Skert C, et al. Ponatinib–Blinatumomab or Imatinib–Chemotherapy for Adult Ph-Positive ALL. N Engl J Med 2026;395:1483-94. doi:10.1056/NEJMoa2606208 · GIMEMA ALL2820, ClinicalTrials.gov NCT04722848.

Ouça o episódio 93

Apresentação: Lucas Lopes · Discussão: Carol Marques, Luiza Pires, Rafael Faust, Eduardo Burlamaqui, Lívia Monteiro e Pedro Moraes
▶ YouTube e 🎧 Spotify: **TMO EPM** · link na bio
📸 Instagram: **@tmoepm**

Material educativo, preparado a partir do artigo citado. Não substitui o julgamento clínico.

© 2026 TMO EPM · resumo do episódio 93 · reprodução ou uso em aulas e materiais somente com autorização (@tmoepm)